

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5097582-03.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: TEREZINHA SOARES ARAUJO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. SAÚDE. CONSULTA COLOPROCTOLOGIA (ONCOLOGIA). NEOPLASIA MALIGNA DO COLON. INÍCIO DO TRATAMENTO. 1ª CONSULTA. PRAZO DA LEI 12.732 HÁ MUITO ULTRAPASSADO. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, confirmando a liminar anteriormente concedida. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e devolva-se à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2025.

5097582-03.2024.4.02.5101

510015325728 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5097582-03.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: TEREZINHA SOARES ARAUJO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora, em face da decisão do juízo, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

"A parte autora requer a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar que os réus, providenciem CONSULTA EM ONCOLOGIA em até 72 horas, com atendimento integral oportuno (tratamento oncológico) no prazo de 10 dias após a consulta.

Pelos laudos médicos trazidos aos autos é possível constatar que a parte autora realmente sofre de enfermidade.

O deferimento imediato da tutela seria aparentemente justo, mas não seria jurídico. A invocação genérica de um direito ideal à saúde previsto na Constituição não é eficaz para dar origem a obrigações. Admite-se que, principalmente, havendo perigo para a vida, o Poder Judiciário atue no sentido de preservá-la, desde que tal intento possa ser alcançado por algo que esteja ao alcance do juiz determinar que seja feito. Neste sentido, obrigar pessoas públicas ou privadas a agir quando a lei mesma não as compele a isto está fora de seu âmbito de possibilidades.

Ainda assim, se no decorrer da instrução houver convencimento do contrário, isto é, de que a tutela é imprescindível para a realização de um legítimo direito do demandante, poderá ser reconsiderada a decisão.

Apenas para que fique claro, se ainda não restou evidente até aqui, o subscritor desta decisão afirma não haver direito subjetivo individual a prestações de saúde por parte do Estado, o que não quer dizer que não exista o direito difuso correspondente ou que esteja de uma vez abdicando do exame de cada caso particular quando outros direitos conexos possam exigir prestação de tal natureza. Por isso mesmo, esta é uma decisão de caráter geral e de texto padronizado, aplicada em todos os casos nos quais nenhuma peculiaridade exija um pronunciamento específico.

Sendo assim, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA."

Em seu recurso, a parte autora reitera que foi diagnosticada com e neoplasia maligna do colon e ainda está aguardando em fila, sem previsão, para a primeira consulta de coloproctologia (oncologia), estando inserida no SER desde 23/09/2024.

Medida liminar deferida no Evento 8.

VOTO

A parte autora junta aos autos o encaminhamento do médico do SUS, com o diagnóstico de adenocarcinoma invasivo, solicitando consulta em oncologia, datado de 16/09/2024 (evento 1, DOC2 pag. 18).

Anexa, também, exame anatomopatológico apontando a existência de adenocarcinoma ulcerado invasivo grau 2, datado de 09/08/2024 (evento 1, DOC2 pag.22)

Paciente: TEREZINHA SOARES ARAUJO
Apoiado: 677219 - CENTRO MEDICO PASTORE
Cód. Apoiado: SFI2000209489201
Solicitante: CRM-RJ-52978710 CARLOS TADEU TOME DE OLIVEIRA
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Pedido: 1291527823
Sexo: Feminino
Dt. Nasc: 14/08/1960
Idade: 63a
Dt. Cadastro: 09/08/2024



CANAL DE ATENDIMENTO ENTRE MÉDICOS

EXAME ANATOMOPATOLÓGICO
Número exame: AP24-168598 / 1291527823

1 Exame macroscópico:

Material recebido para exame em formalina consta de 3 fragmentos irregulares, medindo o maior 0,6 x 0,3 x 0,2 cm e o menor 0,5 x 0,3 x 0,1 cm, constituídos por tecido acastanhado e elástico. Todo material foi submetido ao processo histológico:
1A: (1 bloco(s) / 3 fragmento(s)).

Exame microscópico: Os cortes histológicos corados com H&E evidenciam neoplasia epitelial com arquitetura tubuliforme e contendo material necrobiótico na luz; em cujas células são poligonais, com alta relação núcleo-citoplasma, mitoses atípicas e núcleos hiper cromáticos.

Topografia: CÓLON DESCENDENTE

DIAGNÓSTICO:

- ADENOCARCINOMA ULCERADO INVASIVO (WHO, 2010*) GRAU 2 NESTA AMOSTRA.

O parecer do NAT informa que a consulta e o tratamento oncológico estão indicados ao manejo da condição clínica da Autora e que a mesma está regulada desde 23/09/2024, para consulta ambulatorio 1ª vez - coloproctologia (oncologia). CID: neoplasia maligna do cólon. Classificação de risco amarelo - prioridade 2. posição em fila: 287º (evento 6, PARECER1).

A Lei nº 12.732, de 22.11.2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada no âmbito do SUS, assim estabelece:

"Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso."

Da mesma forma, a Portaria nº 876/13 do Ministério da Saúde, que regula a aplicação da Lei nº 12.732/12, prevê que:

"Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a aplicação da Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa a respeito do primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)."

"Art. 2º Para fins desta Portaria, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna comprovada com:

I - a realização de terapia cirúrgica;

II - o início de radioterapia; ou

III - o início de quimioterapia.

Parágrafo único. Os pacientes sem indicação das terapêuticas antitumorais descritas nos incisos I a III do "caput" terão acesso a cuidados paliativos, incluindo-se entre estes o controle da dor crônica, conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde."

"Art. 3º O prazo de 60 (sessenta) dias fixado no art. 2º da Lei nº 12.732, de 2012, para fins do primeiro tratamento cirúrgico ou quimioterápico ou radioterápico do paciente no SUS, contar-se-á a partir do registro do diagnóstico no prontuário do paciente."

§ 1º O prazo previsto no "caput" poderá ser reduzido por profissional médico responsável, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 2º Não se aplica o prazo previsto no "caput" aos seguintes casos de neoplasia maligna:

I - câncer não melanótico de pele dos tipos basocelular e espinocelular;

II - câncer de tireoide sem fatores clínicos pré-operatórios prognósticos de alto risco; e

III - casos sem indicação de tratamento descritos no art. 2º."

A legislação fala em 60 dias da confirmação do diagnóstico para início do tratamento, que compreende a realização de cirurgia ou início de radioterapia ou quimioterapia.

No entanto, isso não ocorrerá até que a parte autora passe pela 1ª consulta no ambulatório de oncologia, afim de que seja avaliado o tratamento necessário.

Observo que o prazo da legislação de 60 dias já foi ultrapassado, a parte autora ainda se encontra numa posição muito longínqua e a demora no início do tratamento poderá impactar no resultado do tratamento, de modo que entendo presentes o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*.

Após o deferimento da tutela antecipada recursal, o Estado do Rio de Janeiro informou o cumprimento da obrigação de fazer, com o agendamento da parte autora no Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo em 10/12/2024 (evento 18, ANEXO2).

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de **CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO**, confirmando a liminar anteriormente concedida. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e devolva-se à origem.